

NOTULEN

HARI / TANGGAL : SABTU / 10 JANUARI
20262026 PUKUL : 08.30 – 14.00 WIB
AGENDA RAPAT : RAPAT KOORDINASI
KOMITE (ISU PRIORITAS)

PEMIMPIN RAPAT : DIREKTUR RS PRIMA HUSADA
NOTULIS : MAHESA YUDISTIRANTI, S. AP
TEMPAT : HALL SAKURA LANTAI 5

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Penentuan 3 top isu : 1 Diagnosa OGD – DPJP dan ERM menjadi potensi pending, mulai diagnose belum didukung anamnesa sampai dengan pemeriksaan fisik yang benar 2 Klaim pending kasus pneumoni typoid fever meningkat 3 Potensi klaim pending jika ada kasus2 jumlahnya naik atau cost nya tinggi, isian data dukung menuju diagnose harus benar	Kesimpulan : 1. Kurang optimalnya komunikasi antar PPA, menimbulkan ketidaktepatan dalam penentuan indikasi RI dan diagnosa klinis pasien 2. BPJS melakukan pending klaim berdasarkan tren kasus (thypoid fever, pneumoni) 3. Pelaksanaan pelayanan belum sepenuhnya mengacu pada SPO (undang undang)	1. Kurang optimalnya komunikasi antar PPA, menimbulkan ketidaktepatan dalam penentuan indikasi RI dan diagnosa klinis pasien Identifikasi faktor : 1. Man : - Kuarangnya keterampilan komunikasi klinis - variasi kompetensi klinis PPA IGD - budaya hierarki - beban kerja dan kelelahan - fragmentasi peran PPA 2. Methode: - Tidak ada SPO komunikasi antar PPA yang baku - Alur klinis IGD tidak jelas - Tidak ada Clinical pathway IGD - Serah terima tidak terstruktur - Konsultasi spesialis tidak terdokumentasi dengan baik 3. Machine : - SIMRS belum terintegrasi dengan optimal - Form IGD tidak user friendly - Tidak ada clinical decition support (sistem yang mendukung penegakan diagnose) 4. Material :	1. Mutu 2. Kabid 3. Karu

				- Label dan identifikasi pasien belum optimal - Standart acuan penentuan indikasi rawat inap (PPK) belum berjalan optimal 5. Environment: - IGD overcredit - Lingkungan bising dan tidak kondusif - Privasi terbatas untuk diskusi klinis - Tekanan pekerjaan yang tinggi dalam membuat keputusan Analisis Faktor : - siapa saja PPA yang terlibat dalam pengambilan keputusan , apakah kompetensi klinis dan komunikasi mereka setara dan apa hambatannya - Kemampuan komunikasi PPA belum optimal - Tidak adanya standart keputusan rawat inap - Tidak adanya sistem komunikasi klinis terstruktur Rencana Aksi: 1. Membangun proteksi sistem komunikasi klinis 2. Menyediakan time out klinis sebelum keputusan besar 3. Standarisasi kriteria rawat inap dan diagnosis IGD 4. BPJS melakukan pending klaim berdasarkan tren kasus (thypoid fever, pneumoni) Identifikasi faktor : 1. Man : - Pemahaman PPA terhadap kriteria indikasi rawat inap belum seragam - Kompetensi klinis dalam penegakan diagnosis belum optimal	
--	--	--	--	--	--

				- Ketidakselarasan komunikasi antar PPA (DPJP, IGD, perawat) - Kurangnya pemahaman dokter terhadap regulasi dan kebijakan klaim BPJS - Petugas belum memahami penggunaan SIMRS secara optimal 2. Methode: - Standar acuan (PPK) penentuan indikasi rawat inap belum optimal - Alur klinis (clinical pathway) TF dan Pneumonia belum diterapkan optimal - Dokumentasi Rekam Medis belum mendukung pertimbangan rawat inap 3. Machine : - Belum terintegrasinya PPK/standar dalam SIMRS - Jaringan yang belum stabil 4. Material : - Rekam medis tidak lengkap atau tidak sinkron - Ketidaksesuaian diagnosis klinis akhir dengan diagnose klinis awal pasien - Anamnesa awal tidak mencerminkan kondisi klinis sebenarnya - Terbatasnya pemeriksaan penunjang khususnya kasus anak 5. Environment - Kebijakan BPJS lebih ketat pada diagnosis dengan tren tinggi - Perbedaan persepsi antara rumah sakit dan verifikator BPJS	
--	--	--	--	---	--

- Tekanan pelayanan di IGD (overcrowding, waktu terbatas)
- Tingginya beban kasus pasien anak

Analisa Faktor:

Pending klaim BPJS pada kasus Typhoid Fever dan Pneumonia terutama disebabkan oleh belum optimalnya standar acuan penentuan indikasi rawat inap, ketidakkonsistenan penerapan SPO, serta kelengkapan dan kesesuaian dokumentasi medis. Faktor pendukung lainnya meliputi komunikasi antar PPA yang belum efektif, keterbatasan sistem pendukung, dan perbedaan persepsi dengan verifikator BPJS

Rencana Aksi:

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu
1	Ketidaktepatan indikasi rawat inap	Menyusun dan menetapkan standar acuan indikasi rawat inap kasus TF dan Pneumonia	Komite Medik, SMF	1-2 bulan
2	SPO dan clinical pathway belum optimal	Sosialisasi dan penegakan SPO serta clinical pathway TF dan Pneumonia	Manajemen RS, SMF	1 bulan
3	Dokumentasi medis tidak lengkap	Edukasi PPA tentang kelengkapan rekam medis dan justifikasi klinis	Rekam Medis, Komite Medik	1 bulan
4	Ketidaksesuaian diagnosis dan koding	Koordinasi rutin dokter penanggung jawab dan koder sebelum klaim	DPJP, Koder	Berjalan
5	Pending klaim berulang	Audit internal dan pembahasan kasus pending klaim secara berkala	Tim Casemix, PMKP	Bulanan
6	Kurangnya pemahaman kebijakan BPJS	Koordinasi dan klarifikasi rutin dengan verifikator BPJS	Manajemen RS	Triwulan

5. Pelaksanaan pelayanan belum sepenuhnya mengacu pada SPO

Identifikasi faktor :

- Man :
 - Petugas belum memahami isi SPO secara menyeluruh
 - Pelatihan SPO belum merata
 - Kebiasaan kerja lama masih digunakan
 - Beban kerja tinggi → cenderung melewati prosedur
 - Disiplin dan kepatuhan rendah

2. Methode:

				- SPO terlalu panjang dan sulit dipahami - SPO belum disosialisasikan secara efektif - SPO tidak diperbarui sesuai kondisi lapangan - Alur pelayanan di SPO tidak praktis 3. Machine : - Sistem/aplikasi pelayanan belum mendukung alur SPO - Formulir atau checklist SPO tidak tersedia - Keterbatasan alat pendukung pelayanan 4. Material : - Dokumen SPO tidak mudah diakses - Tidak tersedia ringkasan SPO (flowchart/panduan singkat) - Perbedaan versi SPO antar unit 5. Environment - Tekanan waktu pelayanan tinggi - Jumlah pasien/pengguna layanan banyak - Lingkungan kerja kurang kondusif - Budaya mutu dan keselamatan belum kuat Analisa Faktor: • Kurangnya pemahaman dan pembiasaan SPO • SPO yang belum user-friendly • Pengawasan dan evaluasi yang lemah • Tekanan beban kerja dan keterbatasan sarana Rencana Aksi: - Sosialisasi dan refresh SPO secara berkala - Membuat ringkasan SPO (flowchart/checklist) - Menyediakan SPO di area kerja (hardcopy & digital) - Supervisi langsung saat pelayanan	
--	--	--	--	---	--

				- Audit kepatuhan SPO rutin - Intergrasi SPO ke sistem/ aplikasi SIMRS	
--	--	--	--	--	--

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)

Malang, 10 Januari 2026
Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

(Mahesa Yudistiranti, S. AP)

DOKUMENTASI





Nomor : 037/E-UND/DIR/I/2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.

1. **Dwi Novianti, AMd. AK, S. Kes – Kepala Bidang Penunjang Medis**
2. **Puput Sekar Nari Ratih, AMd. Keb, S. E – Kepala Bidang Pelayanan Medis**
3. **drg. Endy Wira Pradana, M,MRS – Kepala Bagian Umum**
4. **Nur Rizkiah Amalia – Casemix Manajer**
5. **dr. Arief Heru Wicaksono Sp. An – Ketua Komite Medik**
6. **dr. Ari Putriani Sp. PK – Ketua Komite Mutu**
7. **Fariz Tiarawan Fadil Cahyono S. Kep.Ns – Ketua Komite Keperawatan**
8. **Sherly Rosita S. Kep. Ns - Komite PPI**
9. **Fadhila Ayu Setyani AMd.Kep - Sekretaris Komite Medik**
10. **Alifia Dian Sukmaningtyas S.Kep.Ns - Sekretaris Komite Mutu**
11. **Lola Novira Risdianti A.Md.Kep – Sekretaris Komite Keperawatan**

di Tempat

Dengan hormat,

Diharap untuk hadir pada:

Hari, Tanggal : Sabtu, 10 Januari 2026
Acara : Rapat Koordinasi Komite
Pukul : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Hall Sakura Lantai - 5

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka diharapkan kehadirannya tepat waktu.

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PLT Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes